

长期小剂量应用硝苯吡啶对糖代谢的影响

牡市二院骨外分院 杨秀芹 刘秀芬

牡市北山宾馆卫生所 王玉敏

短期大量的口服硝苯吡啶(180 mg以上/d)能够引起糖耐量下降,从而导致血糖升高。为了探讨长期小剂量应用硝苯吡啶(20—30 mg/d)能否引起糖耐量异常,本文对13名58岁以上,长期小剂量应用硝苯吡啶的病人进行了调查,并与服用其它血管扩张药和未服药者对比,现将结果报道如下:

1 资料与方法

本文观察对象共649人,均为男性,年龄58岁—81岁,平均65岁。其中冠心病236人,高血压病88人,诊断符合全国内科学术会议心血管组冠心病及高血压命名及诊断标准。共分3组:Ⅰ组113人,为口服硝苯吡啶(20—30 mg/d)超过2年者;Ⅱ组158人,为口服硝酸甘油和硝异山梨醇(消心痛)超过2年者;Ⅲ组383人为对照组,既未服扩血管药者。

分别统计用药1年以后糖尿病的发生率。对其中无糖尿病者,Ⅰ组36例,Ⅱ组32例和Ⅲ组28例做葡萄糖耐量试验。方法为禁甜食2天,第3天抽空腹血糖,然后食馒头100g,2h后采血,以餐后2h血糖

7.8~11.2 mmol/L为糖耐量减低。

2 结果与讨论

调查结果表明,Ⅰ组发生糖尿病6例(5.3%),Ⅱ组7例(4.6%),Ⅲ组18例(4.7%),经统计学处理,3组间差异无显著意义($P>0.05$)。糖耐量试验结果表明,糖耐量减低者分别为Ⅰ组9例(25%),Ⅱ组9例(28%),Ⅲ组6例(21.4%),差异也无显著意义($P>0.05$)。本文调查结果表明,长期小剂量应用硝苯吡啶者糖尿病发生率并不比应用硝异山梨醇,硝酸甘油或不用药者高,提示长期小剂量应用硝苯吡啶并不影响糖代谢。

本文Ⅰ组6例糖尿病病人,坚持口服降糖药,血糖基本控制在7.28—10.08 mmol/L之间,并没有因服硝苯吡啶而使血糖难以控制,间接证明此药对糖代谢并无多大影响。所以冠心病或高血压合并糖尿病者,可以按常规治疗应用此药。但老年人多有动脉硬化,各脏器发生率较正常人群增高,定期复查血糖还是有必要的。

1993—03—24 收稿

安定药物相互作用

密山市8511农场医院 郭郁梅

牡市传染医院 侯丽娜 魏凤芝

安定在临床各科应用甚广,但是对其相互作用报道极少,现报道如下:

1 对机体有利的相互作用

1.1 治疗神经官能症失眠者,将安定与苯巴比妥并用,能增强中枢抑制效应。

1.2 异烟肼可削弱安定的代谢运转,可抑

制安定排泄会明显增加安定清除率。

1.3 安定与麻醉剂合用,发生暂时性低血压,呼吸抑制等反应。

1.4 安定可加强噻嗪类及其它利尿剂抗高血压效应。

1.5 安定与甲氟咪呱合用可使安定血浆廓

清率明显降低。

1.6 安定与芩桂术甘汤合用，用量只需常规量。

2 对机体有害的相互作用

2.1 安定与利眠宁合用引起遗尿。

2.2 安定与单胺氧化酶抑制剂并用时增强中枢神经抑制作用，一般不宜合用。

2.3 安定与度冷丁合用引起呼吸停止。

2.4 服安定患者不宜饮酒。

2.5 双流醒将使安定的作用增强，半衰期延长。它与利多卡因有抗心律失常作用，与 V_k 合用对凝血过程有一定抑制。

1993—03—27收稿

危重抢救中抗生素不合理应用分析

解放军第209医院 刘英山 张锦霞
81874部队卫生所 邱福军

本文随机抽查了所属4所医院1989年—1992年住院危重抢救病历共160份，现将抗生素不合理应用分析报告如下：

1 抗生素使用情况

调查160份住院危重抢救病历中，应用抗生素的有158份(98.8%)。内科系统85份(53.8%)，外科系统73份(46.2%)。在158份病历中，不合理用抗生素的44份(27.8%)，其中内科系统16份，外科系统28份，分别占18.8%和38.4%，外科系统不合理用药明显高于内科系统($P < 0.01$)。158份中抗生素单剂用药为67份(42.2%)，联合用药为91份(57.6%)，单剂用药中出现不合理用药的有19份(28.4%)，联合用药中有25份(27.5%)，两种用法的不合理用药无明显差异($P > 0.05$)。

2 联合用药中的不合理应用

2.1 氨基糖甙类抗生素的联合应用 如庆大霉素和链霉素、妥布霉素和丁胺卡那霉素合用等。此类药物都有耳、肾毒性，2种或3种同时并用后加剧毒性反应。

2.2 抗生素与其它药物联合应用后加剧不良反应。如氨基糖甙类抗生素和速尿等合用，对听神经的损害两者有相加作用，故不宜合用。先锋霉素和速尿、庆大霉素和低分

子右旋糖酐、氯霉素和氟尿嘧啶均可增加不良反应。

2.3 抗生素联合应用减弱其中一药的效果，如羧苄青霉素和链霉素、氯霉素和林可霉素、氨苄青霉素与羧苄青霉素合用均可使后者效果减弱。

2.4 盲目应用抗生素 如高热待查患者给予氨苄青霉素+庆大霉素+氯霉素静滴、妥布霉素肌注、灭滴灵口服，连用10天出现真菌感染后才停用抗生素；心肌梗塞患者出现腹泻，大便镜检(一)，给予肌注先锋Ⅵ号、口服氟呱酸和黄连素7天。这类不合理联合用药，不仅浪费药品，且增加药物的毒副作用。

3 单剂用药中的不合理应用

3.1 选药不当 如流行性出血热合并肺内感染患者，尿素氮和肌酐已超过正常值的情况下仍使用肾毒性药物妥布霉素；重症肝炎患者给予口服复方新诺明、静滴洁霉素，这些药物均可加重肝损害。

3.2 疗程不当 如大面积烧伤合并感染患者，丁胺卡那霉素0.6g/d，静滴，连用21天，直至发生耳鸣、耳聋，规定疗程不应超过10天。

3.3 换药过频 如大面积烧伤合并感染患者，6天内先后换用氨苄青霉素、先锋霉素，